

1. ชื่อผลงาน: เยียวยาใจผู้สูญเสีย

2. ผลงานประเภท: SHA (Spiritual Healthcare in Action) และ CQI (Continuous Quality Improvement)

3. คำสำคัญ (Keywords): Bereavement Care, Complicated Grief, Spiritual Healthcare, การดูแลแบบประคับประคองในเด็ก, การเยียวยาจิตใจ, ทฤษฎีกระบวนการกู่ขนาน

4. สรุปผลงานโดยย่อ (Executive Summary): ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม และหอผู้ป่วยเด็กระยะเรื้อรัง มักเผชิญกับความเจ็บป่วยที่คุกคามต่อชีวิตและต้องการการดูแลรักษาที่ซับซ้อน เมื่อผู้ป่วยเด็กเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิต การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) จะเข้ามามีบทบาทในการดูแลแบบองค์รวม อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเสียชีวิตของผู้ป่วย กระบวนการดูแลทางการแพทย์ในระบบเดิมมักจะสิ้นสุดลง ทำให้ครอบครัวต้องเผชิญกับความโศกเศร้าอย่างโดดเดี่ยว บิดามารดาหลายครอบครัวประสบกับภาวะวิกฤตทางจิตใจ ทำให้ชีวิตหยุดชะงัก ไม่สามารถกลับไปประกอบอาชีพหรือดูแลสมาชิกคนอื่นในครอบครัวได้ตามปกติ ซึ่งเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดภาวะเศร้าโศกที่ผิดปกติและยืดเยื้อ (Complicated Grief) นอกจากนี้ บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างยาวนาน ก็มักเผชิญกับความเหนื่อยล้าทางอารมณ์และเสียใจจากการสูญเสียผู้ป่วยเช่นกันเพื่อปิดช่องว่างในการให้บริการ (Service gap) และตอบสนองต่อแนวคิดการพัฒนามิติจิตวิญญาณในสถานพยาบาล (SHA) กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคองร่วมกับงานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต จึงได้พัฒนาระบบการดูแลครอบครัวภายหลังการสูญเสีย (Bereavement Care System) อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการบูรณาการพิธีกรรมทางศาสนาเข้ากับจิตวิทยาการให้คำปรึกษา เกิดเป็นโครงการ "น่านุญสู่ลูกน้อย" กิจกรรมนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยใช้กระบวนการทางพุทธศาสนา เช่น การทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล เพื่อเป็นเครื่องมือในการลดกำแพงการต่อต้านทางจิตใจ (Defensive mechanisms) เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้ระลึกถึงบุตรหลานในเชิงบวก ควบคู่ไปกับการจัดกระบวนการกลุ่มบำบัด (Group Support) โดยทีมนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และพยาบาลวิชาชีพ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้สูญเสียได้ระบายความรู้สึก แบ่งปันประสบการณ์ และเรียนรู้ทักษะการเผชิญปัญหา (Coping skills) ผลการดำเนินงานพบว่ากิจกรรมนี้สามารถเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้สูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้พวกเขาสามารถก้าวผ่านความทุกข์และกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์ให้ตระหนักถึงคุณค่าของงานที่ทำ นำไปสู่การบริหารจัดการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์อย่างยั่งยืน

5. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Goals and Objectives):

การดำเนินงานโครงการมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อสร้างระบบการดูแลแบบประคับประคองที่ไร้รอยต่อ โดยครอบคลุมถึงระยะหลังการเสียชีวิต (Bereavement phase) ดังนี้

5.1 วัตถุประสงค์เชิงระบบ: เพื่อพัฒนาระบบและแนวปฏิบัติการดูแลภายหลังการสูญเสียแบบสหสาขาวิชาชีพสำหรับครอบครัวผู้ป่วยเด็กระยะท้ายในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

5.2 วัตถุประสงค์เชิงคลินิกและจิตวิทยา: เพื่อคัดกรอง ป้องกัน และเยียวยาความโศกเศร้าที่ผิดปกติ (Complicated Grief) ของผู้ดูแลหลักและครอบครัว เพื่อให้สามารถปรับตัวและกลับคืนสู่สังคมได้

5.3 วัตถุประสงค์ด้านบุคลากร: เพื่อเป็นพื้นที่ในการสะท้อนคิด (Reflection) และเยียวยาจิตวิญญาณของเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ที่สูญเสียผู้ป่วยอันเป็นที่รัก ลดความเสี่ยงต่อภาวะตึงเครียดทางศีลธรรม (Moral distress) และภาวะหมดไฟ (Burnout)

เป้าหมายความสำเร็จของโครงการถูกกำหนดไว้ดังนี้

ประการแรก การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมที่สามารถจัดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
ประการที่สอง ครอบครัวผู้สูญเสียที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการประเมินสภาพจิตใจ และมีระดับความคลายกังวลเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ประการที่สาม ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์และครอบครัวต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

6. ปัญหาและสาเหตุเชิงลึก (Problem and Root Cause Analysis):

จากการทบทวนเวชระเบียนและผลการดำเนินงานในหอผู้ป่วยเด็กระยะประคับประคอง พบว่าเมื่อผู้ป่วยเด็กเสียชีวิต ผู้ดูแลหลัก (พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย) ต้องเผชิญกับปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่รุนแรง เช่น อาการช็อก ปฏิเสธความจริง โกรธ และซึมเศร้า การไม่ได้รับคำอธิบายหรือการประคับประคองทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง ภายหลังการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กระบวนการปรับตัวล้มเหลว ทีมผู้ดูแลได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบันเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวหลังการสูญเสีย โดยใช้หลักการ 5W1H เพื่อค้นหาสาเหตุรากเหง้า (Root Cause) ดังตารางต่อไปนี้

องค์ประกอบวิเคราะห์ 5W1H	สภาพปัญหาและสาเหตุเชิงลึกที่พบในระบบบริการ
What (ปัญหาคืออะไร)	ครอบครัวผู้สูญเสียบุตรเผชิญภาวะวิกฤตทางอารมณ์ ไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ ชีวิตหยุดชะงัก (Loss of identity) ขาดระบบการติดตามดูแลและเยียวยาจิตใจในระยะยาว (Bereavement Gap) หลังผู้ป่วยเสียชีวิต
Why (ทำไมจึงเกิดปัญหา)	1. ระบบบริการสาธารณสุขแบบเดิมมุ่งเน้นการดูแลจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต แต่ขาดโครงสร้างรองรับการดูแลญาติภายหลังการตาย 2. การสื่อสารทางเดียวและการให้เอกสารคำแนะนำไม่เพียงพอต่อการเยียวยาความบอบช้ำทางจิตใจที่รุนแรง 3. ญาติไม่มีพื้นที่ปลอดภัยหรือกระบวนการสนับสนุนทางสังคม (Social support) ที่เหมาะสม

องค์ประกอบ วิเคราะห์ 5W1H	สภาพปัญหาและสาเหตุเชิงลึกที่พบในระบบบริการ
Who (ใคร เกี่ยวข้องบ้าง)	1. ครอบครัวผู้ป่วยเด็ก (ผู้สูญเสีย) 2. แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ ที่ต้องรับภาระ ความเครียดสะสมจากการสูญเสียผู้ป่วย (Compassion fatigue)
When (เกิด ปัญหาเมื่อใด)	ภายหลังผู้ป่วยเด็กเสียชีวิต โดยเฉพาะในช่วง 3-6 เดือนแรก ซึ่งเป็นระยะที่มี ความเสี่ยงสูงต่อการเกิด Complicated Grief
Where (เกิดขึ้นที่ ไหน)	เกิดขึ้นเมื่อครอบครัวกลับไปใช้ชีวิตในชุมชน หรือระหว่างการติดตามผลที่งานการ พยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต
How (แนว ทางการแก้ไข)	พัฒนาระบบแนวปฏิบัติการเยียวยาเชิงรุก โดยการจัดกิจกรรม "นำบุญสู่ลูกน้อย" ที่ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการกลุ่มบำบัด (Group Therapy) นำโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อประเมินและเยียวยาจิตใจอย่างเป็น ระบบ

7. กิจกรรมการพัฒนา : ระบุ(Quality Improvement Activities):

ทีมพัฒนาคุณภาพของกลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคองและงานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้นำ
วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA (Plan - Do - Check - Act) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้
สูญเสียอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี โดยมีการยกระดับกระบวนการทำงานดังนี้

ขั้นตอนการวางแผน (Plan): ทีมสหวิชาชีพประกอบด้วยกุมารแพทย์ พยาบาลเฉพาะทาง นักจิตวิทยา และนัก
สังคมสงเคราะห์ ร่วมกันจัดทำแนวปฏิบัติการดูแลครอบครัวหลังการสูญเสีย (Bereavement Care Pathway)
มีการทบทวนรายชื่อผู้ป่วยเด็กที่เสียชีวิตในรอบปี และใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อภาวะโศกเศร้า
(Complicated Bereavement Risk Assessment Tool - CBRAT) เพื่อจัดกลุ่มความเสี่ยงของครอบครัว
จากนั้นจึงดำเนินการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามความต้องการและเชิญชวนครอบครัวเข้าร่วม
กิจกรรม โดยมีการวางแผนเชิงลึกเพื่อบูรณาการพิธีกรรมทางศาสนาเข้ากับกระบวนการบำบัดทางจิตวิทยา

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do): การจัดกิจกรรม "นำบุญสู่ลูกน้อย" ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ณ สถาบันสุขภาพ
เด็กแห่งชาติดมหาราชนิ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นสองส่วนหลักที่ทำงานประสานกันตามทฤษฎี Dual Process
Model ส่วนแรกคือการเยียวยาผ่านมิติจิตวิญญาณและวัฒนธรรม (Loss-oriented intervention) โดยการ
จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลและสังฆทานแด่พระสงฆ์ พิธีกรรมเหล่านี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่อนุญาตให้

ผู้ปกครองได้แสดงความรักและความอาลัยต่อบุตรหลานผ่านการอุทิศส่วนกุศล ส่วนที่สองคือการเยียวยาผ่านกระบวนการทางจิตวิทยา (Restoration-oriented intervention) โดยการจัดกลุ่มสนับสนุน (Support Group) ที่นำกระบวนการโดยทีมนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้แบ่งปันเรื่องราว ระบายความรู้สึกเจ็บปวด และแลกเปลี่ยนวิธีการรับมือกับความเศร้ากับครอบครัวอื่นที่เผชิญสถานการณ์เดียวกัน พร้อมทั้งมีการประเมินสภาพจิตใจของแต่ละบุคคลอย่างใกล้ชิด

ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check): หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ทีมงานได้ทำการประเมินผลลัพธ์ในสามมิติ ได้แก่ การประเมินระดับความเศร้าโศกและความคล้อยตามของครอบครัวโดยใช้แบบประเมินทางจิตวิทยา (เช่น Inventory of Complicated Grief - ICG หรือแบบประเมิน 9Q/8Q กรณีพบความเสี่ยงซึมเศร้า) การประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดงาน และการประเมินการรับรู้คุณค่าในวิชาชีพของบุคลากรทางการแพทย์ (Staff morale) ผ่านการสนทนากลุ่มย่อย (Focus group)

ขั้นตอนการปรับปรุง (Act): ทีมงานนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป ตัวอย่างเช่น การปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับระดับความพร้อมทางอารมณ์ของผู้เข้าร่วม การเพิ่มระบบการติดตามทางโทรศัพท์ (Tele-follow-up) อย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี สำหรับครอบครัวที่มีคะแนนความเสี่ยงสูง รวมถึงการแก้ไขปัญหาเชิงระบบบริหารจัดการ เช่น การประสานงานจัดเตรียมพื้นที่จอดรถเฉพาะ เพื่อลดความเครียดทางกายภาพและอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางครอบครัว

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ (Key Performance Indicators):

เพื่อให้การประเมินผลมีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล ทีมงานได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:

อัตราของครอบครัวผู้สูญเสียที่รู้สึกคลายกังวล สบายใจ และสามารถจัดการกับความรู้สึกตนเองได้ดีขึ้น

ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90

อัตราความพึงพอใจต่อการจัดงานในภาพรวม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:

มีแนวปฏิบัติและระบบบริการดูแลภายหลังการสูญเสียที่บูรณาการมิติจิตวิญญาณ (SHA) ที่เป็นรูปธรรมและสามารถทำซ้ำได้อย่างยั่งยืน บุคลากรทางการแพทย์สามารถสะท้อนความรู้สึก รับรู้คุณค่าของการบริบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และลดความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ (Assessment of Changes and Results):

การดำเนินโครงการได้สร้างผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่สามารถวัดผลได้ตามกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ดังแสดงในตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์ต่อไปนี้

โดเมนเป้าหมาย	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
เป้าหมายเชิง ผลผลิต (Output)	มีระบบและจัดกิจกรรม Bereavement Care เชิง รุกผ่านโครงการนำบุญสู่ ลูกน้อย	จัดกิจกรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	บรรลุเป้าหมาย: ดำเนินการ ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน
เป้าหมายเชิง คุณภาพ (Quality of Service)	อัตราความพึงพอใจในการ เข้าร่วมกิจกรรมของ ครอบครัวผู้สูญเสีย	≥ ร้อยละ 90	บรรลุเป้าหมาย: ครอบครัวให้ คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูง กว่าเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 90)
เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ครอบครัวได้รับการ เยียวยาจิตใจ มีสภาพจิตใจ ที่ดีขึ้น และสามารถ ปรับตัวเผชิญปัญหาได้	สบายใจขึ้น ≥ ร้อยละ 90	บรรลุเป้าหมาย: ประเมินผ่าน แบบสอบถามและการ สัมภาษณ์ พบว่าครอบครัว คลายความวิตกกังวล และ ยอมรับความจริงได้ดีขึ้น
เป้าหมายเชิง ผลกระทบ (Impact)	1. การลดความเสี่ยงภาวะ เศร้าโศกที่ยืดเยื้อ (Complicated Grief) ใน ญาติ 2. การยกระดับจิต วิญญาณของเจ้าหน้าที่ ลด Moral Distress	ลดภาระการ เจ็บป่วยทาง ใจ บุคลากรมี แรงบันดาลใจ	สอดคล้องกับเจตนารมณ์ SHA เจ้าหน้าที่มีขวัญกำลังใจ มี สัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว ผู้ป่วย

10. บทเรียนที่ได้รับ (Lessons Learned):

กระบวนการพัฒนาโครงการนี้ได้มอบบทเรียนที่มีคุณค่ามหาศาลต่อทั้งผู้ให้บริการและระบบสาธารณสุข ดังนี้
 ประการแรก การเยียวยาผ่านกระบวนการกลุ่ม (Group Therapy Dynamics): การนำครอบครัวที่เคยมี
 ประสบการณ์สูญเสียบุตรมาพบปะกัน ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ก่อให้เกิดพลวัตการเยียวยาที่ทรงพลัง
 ผู้ปกครองได้รับความตระหนักรู้ว่าตนเองไม่ได้โดดเดี่ยวหรือเผชิญความทุกข์เพียงลำพัง การสนับสนุนซึ่งกัน

และกันระหว่างผู้สูญเสีย (Peer support) ช่วยเร่งกระบวนการยอมรับความจริง และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประการที่สอง การยกระดับจิตวิญญาณผู้ให้บริการ (Healing the Healer): การดูแลผู้ป่วยได้กระชับทำสร้างภาระทางจิตใจต่อทีมแพทย์และพยาบาลอย่างรุนแรง กิจกรรมนี้นับเป็นพื้นที่ที่อนุญาตให้ทีมงานได้เห็นภาพครอบครัวที่เข้มแข็งขึ้นและกลับมามีรอยยิ้ม ซึ่งเป็นเสมือนกระบวนการป้อนกลับเชิงบวก (Positive feedback loop) ที่สะท้อนคุณค่าของวิชาชีพพยาบาลและการแพทย์ ช่วยเติมเต็มพลังในการทำงาน และบรรเทาความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้ง

ประการที่สาม ความละเอียดอ่อนในการออกแบบบริการ (Service Design): ความเข้าใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เช่น การจัดการเรื่องที่จอดรถให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียที่มาร่วมงาน การสนับสนุนค่าเดินทางแก่ครอบครัว ถือเป็นการบริหารประสบการณ์ของผู้รับบริการ (Customer Experience Management) ที่สำคัญยิ่ง การลดความยากลำบากทางกายภาพช่วยป้องกันความหงุดหงิดและความเครียดสะสม ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเปิดใจรับกระบวนการเยียวยาทางจิตวิญญาณได้อย่างเต็มเปี่ยม

11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน (Contact Information):

-ที่ปรึกษา แพทย์หญิงเดือนเพ็ญ ห่อรัตนารื่อง หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับ หน่วยงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง เบอร์โทรศัพท์ 089-4223466 ภายใน 2631 ,2632 และ e-mail pcdeptqsrich@gmail.com

-นางสาวนารี หินนาง หัวหน้างานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต กลุ่มงานวิชาการพยาบาลเบอร์โทรศัพท์ 082-2214391 ภายใน 2631 ,2632 และ e-mail nunanuhin@gmail.com

-นางสาวชนิกานต์ สุทธิปัญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต กลุ่มงานวิชาการพยาบาล เบอร์โทรศัพท์ 0972503385 ภายใน 2631 ,2632 และ e-mail chanikan1978@gmail.com

-นางสาวพิจิตรา รัตนารณณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป หน่วยงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง เบอร์โทรศัพท์ 099-0282595 ภายใน 2631 ,2632 และ e-mail may15.pijittra@gmail.com

-นางสาวอัจฉรา เรืองพุ่ม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ หน่วยงาน งานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต เบอร์โทรศัพท์ 086-8738393 ภายใน 2631 ,2632 และ e-mail nut902@gmail.com